



MÓDULO 8

Abordagem integrada e inovação nas DCNT

Rui Poínhos

ruipoinhos@utad.pt

Cecília Morais

ceciliam@utad.pt

Conteúdos

1. Promoção da saúde e intervenção multidisciplinar

- 1.1. Saúde, bem-estar e qualidade de vida
- 1.2. Da psicologia da saúde à intervenção nutricional nas DCNT
- 1.3. Abordagem multidisciplinar na saúde e na doença

2. Mudança de comportamentos em nutrição e saúde

- 2.1. Modelos de mudança comportamental
- 2.2. Comportamento alimentar: conceitos, avaliação e uso clínico



Rui Poínhos

3. Modelos integrados de gestão das DCNT

- 3.1. Cuidados baseados no valor (*value-based healthcare*)
- 3.2. Medicina personalizada e gestão preditiva
- 3.3. Estudos de caso: análise de boas práticas internacionais

4. Inovação na gestão das DCNT

- 4.1. Tecnologias digitais na saúde
- 4.2. Inteligência artificial e *big data* na prevenção e gestão das DCNT



Cecília Morais

Avaliação

- **Exame final**, que incidirá sobre os conteúdos dos **temas 1 e 2**:
 - Poderá incluir questões de verdadeiro ou falso, escolha múltipla, resposta curta ou desenvolvimento.
 - No caso de questões de selecção (verdadeiro/falso ou escolha múltipla), os descontos a aplicar no caso de respostas erradas serão determinados com base na probabilidade de acerto ao acaso, de modo a que o valor esperado do somatório das cotações de respostas dadas ao acaso seja nulo.
- **Trabalho escrito**, referente aos conteúdos dos **temas 3 e 4**.



- **Classificação final do módulo**: média das classificações das duas componentes (exame e trabalho).

Referências

- Referências principais:
 - GBD 2019 Risk Factors Collaborators. Global burden of 87 risk factors in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet. 2020;396(10258):1223-1249.
 - Global strategy on digital health 2020-2025. Geneva: World Health Organization; 2021.
 - Leal I, Ribeiro JL (coord.). Manual de psicologia da saúde. Lisboa: Pactor, 2021.
 - World Health Organization. Global status report on noncommunicable diseases 2014. World Health Organization, 2014.
- Para cada tema abordado, serão indicadas referências adicionais específicas.

Conteúdos

1. Promoção da saúde e intervenção multidisciplinar

- 1.1. Saúde, bem-estar e qualidade de vida
- 1.2. Da psicologia da saúde à intervenção nutricional nas DCNT
- 1.3. Abordagem multidisciplinar na saúde e na doença

2. Mudança de comportamentos em nutrição e saúde

- 2.1. Modelos de mudança comportamental
- 2.2. Comportamento alimentar: conceitos, avaliação e uso clínico

Saúde, bem-estar e qualidade de vida

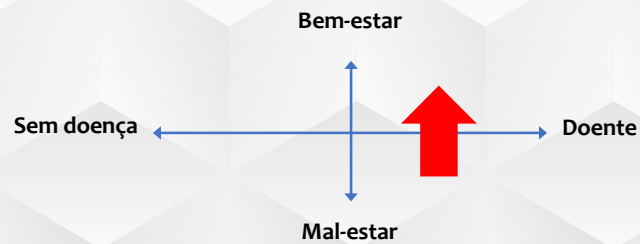
- Quais as diferenças e relações entre os conceitos de **saúde**, **bem-estar** e **qualidade de vida**?



Saúde e doença

- **Saúde:**

- Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença.



- É possível viver saudavelmente (*i.e.* sentir-se bem) tendo uma doença.

OMS, 1946; Leal & Ribeiro, 2021

Saúde e doença

- **Doenças crónicas:**

- Geralmente multifactoriais;
- São geridas em vez de curadas;
- Duração prolongada e progressão lenta.



- Potencial para abordagens e intervenções diversificadas e multidisciplinares.



Leal & Ribeiro, 2021

Saúde e doença

- Perante o diagnóstico de uma doença grave, as pessoas reagem para se ajustar e exibem reacções emocionais à possibilidade de terem essa doença e igualmente a um diagnóstico da mesma.
- Um bom ajustamento depende das estratégias de *coping* (forma de lidar com a situação) usadas:
 - Esforços comportamentais e cognitivos, em mudança constante, que visam gerir experiências internas ou externas específicas, consideradas como excedendo os recursos pessoais.
- Discrepância entre o risco associado a uma doença vs. preocupação com a mesma.
 - E.g. estudo de 2002 perguntava aos participantes (portugueses) qual a doença que mais os preocupava: 63,1% referiram o cancro, 17,8% a SIDA, e apenas 7,7% as DCV (principal causa de morte em Portugal).

Leal & Ribeiro, 2021

Bem-estar



Dodge et al., 2012

Bem-estar

- **Bem-estar subjectivo:**

- Avaliação cognitiva e afectiva que os indivíduos fazem da sua própria vida, de acordo com os seus próprios critérios;
- Experiência interna subjectiva, independente dos padrões de felicidade externos;
- Diferente de outros conceitos de bem-estar (e.g. bem-estar psicológico), que definem critérios externos positivos (e.g. autonomia, auto-aceitação, relações positivas com os outros).



Três componentes:

- Satisfação com a vida (como um todo ou com domínios específicos);  Domínio cognitivo
- Experiência (frequência e intensidade) de emoções positivas;  Domínio afectivo
- Experiência (frequência e intensidade) de emoções negativas.

Bem-estar

- **Factores associados ao bem-estar subjectivo:**

- Personalidade, especialmente neuroticismo (instabilidade emocional e dificuldade de adaptação a diferentes contextos) e extroversão (quantidade e intensidade das relações interpessoais);
- Optimismo, auto-estima;
- Factores genéticos;
- Satisfação com a relações interpessoais;
- Eventos de vida significativos (impacto dependente da valorização pessoal);
- Condições de vida, contexto socio-económico e cultural.

Qualidade de vida

- **Qualidade de vida:**

- Diversas conceptualizações e definições;
- Avaliação que a pessoa faz de quão bem correm múltiplos aspectos da sua vida, incluindo a reacção emocional aos acontecimentos da vida, disposição geral, satisfação com a vida em geral, com o trabalho e com as relações pessoais;
- Estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença ou incapacidade;
- Diversas outras definições incluem a noção de (sensação/ percepção de) bem-estar;
- Diferença entre as expectativas pessoais e a experiência actual.

Leal & Ribeiro, 2021

Qualidade de vida

TABLE 1.3 - WHOQOL PILOT ASSESSMENT DOMAINS AND FACETS

Domain I	Physical		Domain IV	Social relationships
1	Pain and discomfort		17	Personal relationships
2	Energy and fatigue		18	Social support
3	Sexual activity		19	Activities as provider/supporter
4	Sleep and rest			
5	Sensory functions		Domain V	Environment
Domain II	Psychological		20	Freedom, physical safety and security
6	Positive feelings		21	Home environment
7	Thinking, learning, memory and concentration		22	Work satisfaction
8	Self-esteem		23	Financial resources
9	Bodily image and appearance		24	Health and social care: accessibility and quality
10	Negative feelings		25	Opportunities for acquiring new information and skills
Domain III	Level of independence		26	Participation in and opportunities for recreation/ leisure activities
11	Mobility		27	Physical environment (pollution/noise/traffic/climate)
12	Activities of daily living		28	Transport
13	Dependence on medicinal substances and medical aids		Domain VI	Spirituality/religion/personal beliefs
14	Dependence on nonmedicinal substances (alcohol, tobacco, drugs)			
15	Communication capacity			
16	Work capacity			Overall quality of life and general health perceptions

WHO, 2012; www.who.int

Qualidade de vida

WHOQOL-BREF

Por favor leia cada pergunta, veja como se sente a respeito dela, e ponha um círculo à volta do número da escala para cada pergunta que lhe parece que dá a melhor resposta.

		Muito Má	Má	Nem Boa Nem Má	Boa	Muito Boa
1 (G1)	Como avalia a sua qualidade de vida?	1	2	3	4	5

		Muito Insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito nem insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito
2 (G4)	Até que ponto está satisfeito(a) com a sua saúde?	1	2	3	4	5

Qualidade de vida

As perguntas seguintes são para ver até que ponto sentiu certas coisas nas duas últimas semanas.

		Nada	Pouco	Nem muito nem pouco	Muito	Muitíssimo
3 (F1.4)	Em que medida as suas dores (físicas) o(a) impedem de fazer o que precisa de fazer?	1	2	3	4	5
4 (F11.3)	Em que medida precisa de cuidados médicos para fazer a sua vida diária?	1	2	3	4	5
5 (F4.1)	Até que ponto gosta da vida?	1	2	3	4	5
6 (F24.2)	Em que medida sente que a sua vida tem sentido?	1	2	3	4	5
7 (F5.3)	Até que ponto se consegue concentrar?	1	2	3	4	5
8 (F16.1)	Em que medida se sente em segurança no seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
9 (F22.1)	Em que medida é saudável o seu ambiente físico?	1	2	3	4	5

Qualidade de vida

As seguintes perguntas são para ver **até que ponto** experimentou ou foi capaz de fazer certas coisas nas duas últimas semanas.

		Nada	Pouco	Moderadamente	Bastante	Completamente
10 (F2.1)	Tem energia suficiente para a sua vida diária?	1	2	3	4	5
11 (F7.1)	É capaz de aceitar a sua aparência física?	1	2	3	4	5
12 (F18.1)	Tem dinheiro suficiente para satisfazer as suas necessidades?	1	2	3	4	5
13 (F20.1)	Até que ponto tem fácil acesso às informações necessárias para organizar a sua vida diária?	1	2	3	4	5
14 (F21.1)	Em que medida tem oportunidade para realizar actividades de lazer?	1	2	3	4	5

		Muito Má	Má	Nem boa nem má	Boa	Muito Boa
15 (F9.1)	Como avaliaria a sua mobilidade [capacidade para se movimentar e deslocar por si próprio(a)]?	1	2	3	4	5

Qualidade de vida

As perguntas que se seguem destinam-se a avaliar se se sentiu **bem ou satisfeito(a)** em relação a vários aspectos da sua vida nas duas últimas semanas.

		Muito Insatisfeito	Insatisfeito	Nem satisfeito nem insatisfeito	Satisfeito	Muito Satisfeito
16 (F3.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com o seu sono?	1	2	3	4	5
17 (F10.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com a sua capacidade para desempenhar as actividades do seu dia-a-dia?	1	2	3	4	5
18 (F12.4)	Até que ponto está satisfeito(a) com a sua capacidade de trabalho?	1	2	3	4	5
19 (F6.3)	Até que ponto está satisfeito(a) consigo próprio(a)?	1	2	3	4	5
20 (F13.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com as suas relações pessoais?	1	2	3	4	5
21 (F15.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com a sua vida sexual?	1	2	3	4	5
22 (F14.4)	Até que ponto está satisfeito(a) com o apoio que recebe dos seus amigos?	1	2	3	4	5
23 (F17.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com as condições do lugar em que vive?	1	2	3	4	5
24 (F19.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com o acesso que tem aos serviços de saúde?	1	2	3	4	5
25 (F23.3)	Até que ponto está satisfeito(a) com os transportes que utiliza?	1	2	3	4	5

Qualidade de vida

As perguntas que se seguem referem-se à **frequência** com que sentiu ou experimentou certas coisas nas duas últimas semanas.

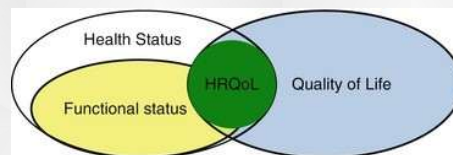
		Nunca	Poucas vezes	Algumas vezes	Frequentemente	Sempre
26 (F8.1)	Com que frequência tem sentimentos negativos, tais como tristeza, desespero, ansiedade ou depressão?	1	2	3	4	5

Canavarro et al., 2017

Qualidade de vida

- **Qualidade de vida relacionada com a saúde:**

- Não consiste na ausência de doença ou sofrimento;
- Qualidade de vida associada a características da doença, dos sintomas e dos tratamentos;
- Actualmente aceite como resultado (*end-point*) central na tomada de decisão, ao nível da morbilidade e mortalidade.



- Aspectos comuns a qualquer pessoa e condição;
- Aspectos específicos da doença ou condição clínica;
- Aspectos individuais.

Leal & Ribeiro, 2021; Upton & Upton, 2015; Sosnowski et al., 2017

Qualidade de vida

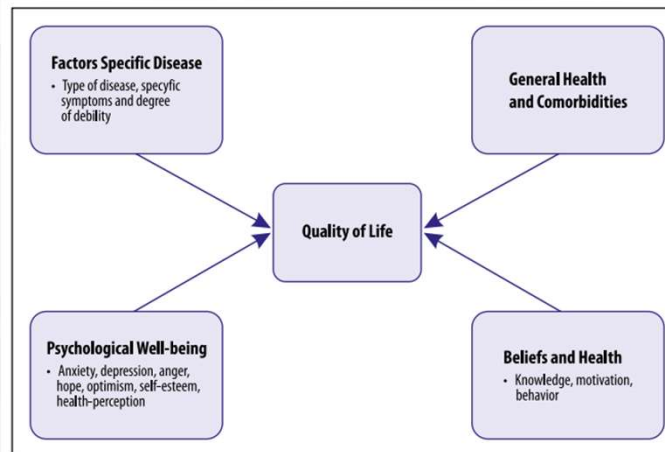


Figure 2. Components of the concept of quality of life conditioned by health at the micro level.

Leal & Ribeiro, 2021; Upton & Upton, 2015; Sosnowski et al., 2017

Conteúdos

1. Promoção da saúde e intervenção multidisciplinar

- 1.1. Saúde, bem-estar e qualidade de vida
- 1.2. Da psicologia da saúde à intervenção nutricional nas DCNT
- 1.3. Abordagem multidisciplinar na saúde e na doença

2. Mudança de comportamentos em nutrição e saúde

- 2.1. Modelos de mudança comportamental
- 2.2. Comportamento alimentar: conceitos, avaliação e uso clínico

Abordagem multidisciplinar

- **Psicologia:**
 - Estudo da mente e do comportamento.
- **Psicologia clínica:**
 - Aproximação (histórica) à medicina;
 - Abordagem individual(izada) e foco na prática/ intervenção.
- **Psicologia da saúde:**
 - Promoção e protecção da saúde, prevenção e tratamento de doenças;
 - Etiologia, diagnóstico, cuidados de saúde e políticas;
 - Importância dos estilos de vida (comportamentos).
- **Psicologia clínica da saúde:**
 - Integração biopsicossocial;
 - Saúde física e mental.

Leal & Ribeiro, 2021

Abordagem multidisciplinar

- Reconhecida há décadas como necessária para a prevenção de doenças e promoção da saúde;
- Interacção entre factores relacionados com diversas áreas;
- Uso de conhecimentos de diferentes áreas nas abordagens.
- **Importância da psicologia para a intervenção nutricional:**
 - Estudo de determinantes, mediadores e consequências dos comportamentos;
 - Visão transversal, processual e desenvolvimental;
 - Foco no desenvolvimento de recursos;
 - Abordagem humanista;
 - Importância de factores psicológicos e sociais na alimentação;
 - Optimização de intervenções.

Especificidades associadas ao desenvolvimento e tratamento de diferentes patologias, em particular DCNT.

Leal & Ribeiro, 2021

Obesidade

- Não é classificada como patologia psiquiátrica (perturbação do comportamento alimentar).
 - No entanto, influência de diversos factores psicológicos no desenvolvimento e tratamento.
- Frequentemente insucesso a longo prazo das intervenções para redução ponderal.
 - Importância da consideração dos factores psicossociais;
 - Avaliação para definir o plano de intervenção mais adequado.
- Comportamento alimentar:
 - Padrões de restrição;
 - Desinibição, ingestão externa, (sobre-) ingestão emocional;
 - Ingestão compulsiva;
 - Ingestão motivada pela recompensa.

Leal & Ribeiro, 2021

Obesidade

- Enquadramento da terapêutica dietética numa abordagem multidisciplinar.
 - Prescrição de exercício físico vs. conselhos para aumento da actividade física (abordagem centrada na mudança dos estilos de vida, modificação de rotinas).
 - Psicoterapia vs. utilização de técnicas e estratégias específicas (e.g. reestruturação cognitiva, terapia cognitivo comportamental).

Obesidade

Controlo de estímulos

- Envolve a identificação de estímulos que podem encorajar a ingestão acidental de alimentos e a identificação e limitação da exposição a situações de alto risco.
- E.g. aprender detalhadamente a seleccionar os alimentos a adquirir, fazer compras quando não se tem fome, manter os alimentos altamente energéticos fora de casa, limitar as horas e os locais onde se come, evitar conscientemente situações em que se come em excesso.

Resolução de problemas

- Processo de definir um problema, gerar possíveis soluções, avaliar e escolher a melhor solução, implementar o comportamento, avaliar resultados e, se necessário, reavaliar alternativas.

Reestruturação cognitiva

- Ensina os doentes a identificar, desafiar e corrigir os pensamentos negativos que prejudicam os seus esforços para perder peso e mantê-lo.

Raymond & Morrow, 2020

Doença coronária

- Variáveis comportamentais e psicossociais que contribuem para o risco de doença coronária e para a evolução clínica e prognóstico:
 - Baixo estatuto socio-económico;
 - Falta de suporte social e isolamento social;
 - Stresse laboral e familiar;
 - Estados emocionais negativos (depressão, ansiedade);
 - Comportamento/ hostilidade do tipo A.
- Importante considerar no tratamento e recuperação:
 - Avaliação individualizada; processo de ajustamento; psicoterapia;
 - Exploração das crenças sobre saúde, controlo percebido e estratégias de coping adoptadas (considerar experiências anteriores).



Promoção de factores de risco

Baixa adesão terapêutica

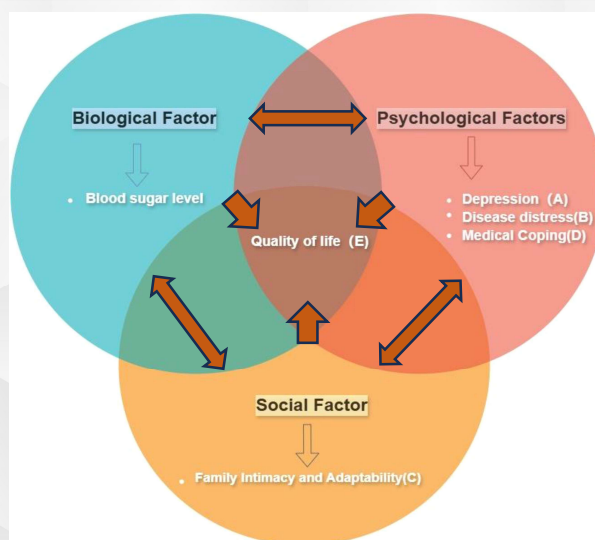
Leal & Ribeiro, 2021

Acidente vascular cerebral

- Alterações cognitivas (e.g. atenção, percepção, memória, função executiva) e funcionais:
 - Dificuldades na participação em actividades (aquisição de alimentos, preparação de refeições);
 - Menor retenção e uso de informação;
 - Diminuição da colaboração e participação activa nos tratamentos.
- Alterações psico-emocionais (e.g. depressão, apatia, agressividade, frustração):
 - Desinvestimento na saúde e auto-cuidados;
 - Menor adesão terapêutica;
 - Dificuldade na distinção entre incapacidade e desinteresse.

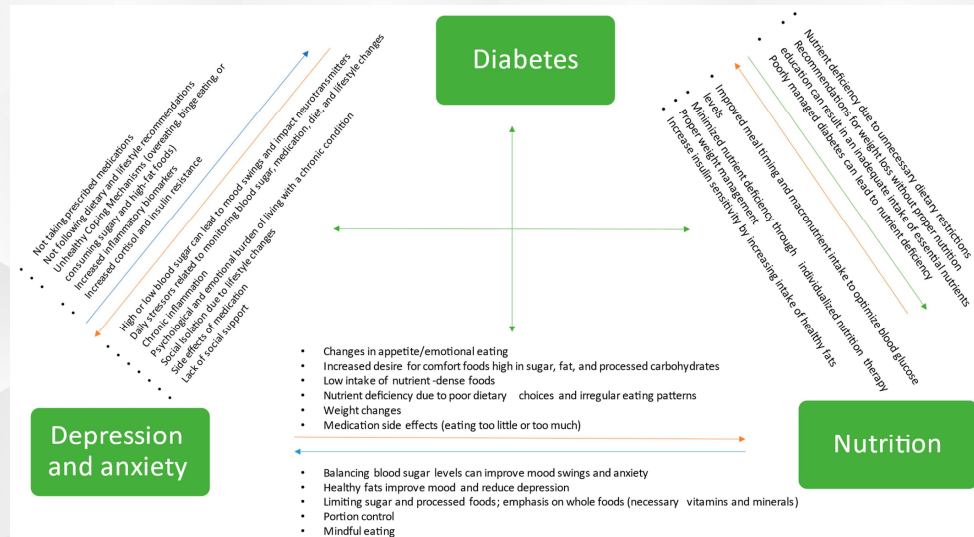
Leal & Ribeiro, 2021; van Heugten et al., 2021; Lekoubou et al., 2023; Butsing et al., 2024; Jaywant & Keenan, 2024;

Diabetes



Chen et al., 2024; Leal & Ribeiro, 2021

Diabetes



Basiri et al., 2023

Literacia em saúde

- O que é literacia (em saúde)?
- De que forma se distingue (ou não) de “conhecimento”?



Literacia em saúde

O que é Literacia em Saúde?

A Literacia em Saúde é um instrumento de promoção de saúde, definido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como o conjunto de competências cognitivas e sociais e a capacidade da pessoa para aceder, compreender, avaliar e aplicar informação em saúde, por forma a promover e a manter uma boa saúde (Figura 2).



Figura 2: Competências de Literacia em Saúde.

Literacia em saúde

- Importância sobretudo em relação a aspectos que implicam um papel activo do doente:
 - Mudança de hábitos alimentares.
- Capacitação e participação informada.
- Dois elementos fundamentais: tarefas e competências.
- Determinada por uma complexidade de factores:
 - Pessoais (e.g. problemas de saúde, competências emocionais e cognitivas, literacia numérica);
 - Sociais e culturais (e.g. objectivos do sistema escolar, crenças sociais acerca da saúde);
 - Influência do sistema de cuidados de saúde (e.g. qualidade da informação).

Literacia em saúde

Literacia funcional/básica

- Competências básicas suficientes para obter informação de saúde e aplicar esse conhecimento num conjunto de acções recomendadas.

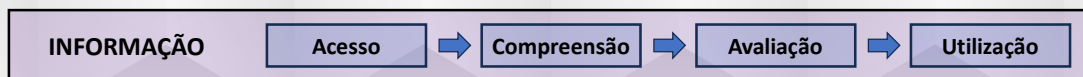
Literacia interativa ou comunicativa

- Competências mais avançadas que permitem compreender e extrair informação de diferentes fontes, aplicar essa informação a novas circunstâncias, interagir com outros e tomar decisões.

Necessidade ter em consideração nas abordagens

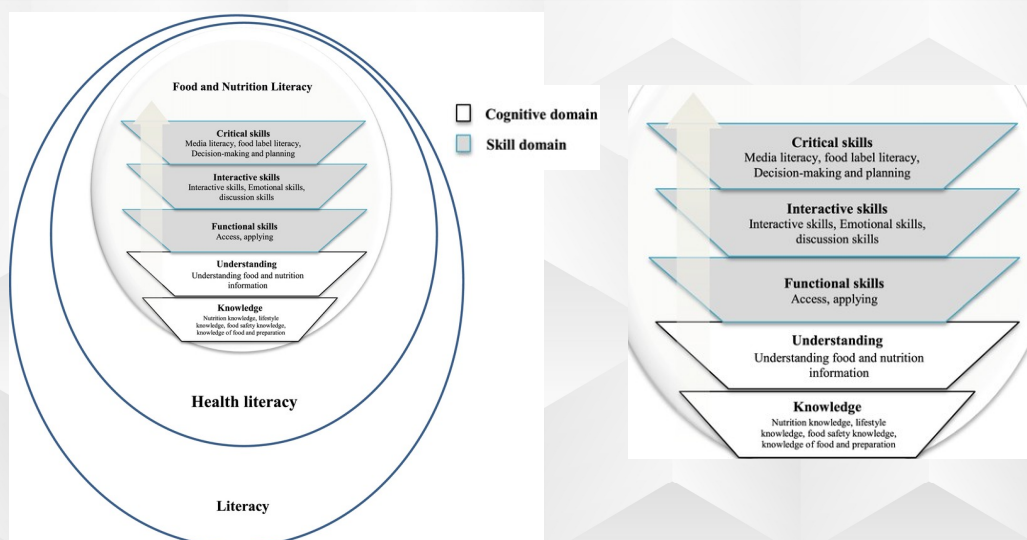
Literacia crítica

- Competências avançadas que podem ser utilizadas para uma análise crítica da informação e para a utilizar para exercer maior controlo sobre as situações com impacto na saúde.



Nutbeam & Lloyd, 2021; Leal & Ribeiro, 2021

Literacia em saúde



Doustmohammadian et al., 2022

Literacia em saúde

Literacia mediática

- Capacidade de avaliar criticamente mensagens dos media.

Literacia fundamental

- Competências e estratégias de leitura, fala, escrita e numeracia.

Literacia científica

- Competências inerentes à ciência e tecnologia da numeracia.

Literacia cívica

- Competências que permitam a tomada de consciência de questões públicas.

Literacia cultural

- Capacidade de reconhecer e utilizar a visão do mundo, crenças colectivas, costumes e identidade social para interpretar a informação de saúde e actuar em conformidade.

Necessidade ter em consideração nas abordagens

Possibilidade de utilização prática

Adesão terapêutica

- Extensão em que o comportamento da pessoa corresponde à prescrição ou indicações dadas pelo profissional de saúde (e.g. aconselhamento ou plano alimentar, estilos de vida).
 - Três componentes: **iniciação**, **implementação** e **descontinuação**.
- Factor determinante do sucesso das intervenções, nomeadamente no âmbito das DCNT.
 - A não adesão é determinada por diversos factores, relacionados com o indivíduo, o prescritor e externos.
 - Interação entre factores, tornando difícil determinar os seus contributos.
- A adesão implica, numa primeira fase, **concordância** com as indicações ou com a prescrição.
 - Posteriormente, deve manter-se o comportamento, com necessidade de acompanhamento cada vez mais reduzida, até este ser mantido em total autonomia.
- **Importância da literacia para reduzir a influência de recomendações sem base científica.**

Adesão terapêutica

- Quatro tendências que caracterizam as pessoas:
 - **O Defensor:** responder prontamente às expectativas externas e internas;
 - **O Questionador:** questionar todas as expectativas, só respondendo positivamente se lhe fizerem sentido;
 - **O Forçado:** responder às expectativas externas, impondo-as a si mesmo;
 - **O Rebelde:** resistir a todas as expectativas.
- As intervenções devem ser adequadas às expectativas, de acordo com estas tendências.

